

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 – 17	Bezeichnung des Dokumentes: Förderung der Harnkontinenz in Anlehnung an den Expertenstandard „Förderung der Harnkontinenz in der Pflege“ 2014	

Durchführende:

- Pflegefachkraft (PFK)/Pflegehilfskraft (PHK)
- PFE für Kontinenzförderung

Pflegeziel:

Bei jedem Patienten wird die Harnkontinenz erhalten oder gefördert. Identifizierte Harninkontinenz wird beseitigt, weitestgehend reduziert bzw. kompensiert.

Es gilt der Grundsatz: kontinenzfördernde Maßnahmen haben Vorrang vor inkontinenzkompensierenden Maßnahmen

Risiken und Ursachen bei Inkontinenz (Grundlage für Differenzial-Assessment) :

kognitive Einschränkungen, körperliche Einschränkungen (insbesondere der Mobilität), Erkrankungen (Schlaganfall, Multiple Sklerose, Morbus Parkinson, Demenz, Diabetes mellitus), Prostataprobleme - nur Männer (Erkrankungen der Prostata/Operationen der Prostata), Medikamente (Diuretika, Anticholinergika, Psychopharmaka, Opiate), Obstipation, Harnwegsinfektionen inklusive Antibiotogramme, Belastung des Beckenbodens durch Schwangerschaften/Entbindungen, Adipositas (BMI über 29), Lageveränderung/ Vergrößerung der Gebärmutter, sexualisierte Gewalt mit Verletzungen im Beckenboden-/Vaginalbereich, umgebungsbedingte Risikofaktoren (Schwierigkeiten hinsichtlich der Erreichbarkeit, Nutzbarkeit und Zugänglichkeit zur Toilette, Erreichbarkeit der Klingel, Lichtverhältnisse, fehlende Handläufe/Haltegriffe, fehlende WC-Sitzerhöhung, schlecht beschilderte, schlecht beleuchtete oder verschmutzte Toiletten, weite Wege, Türschwellen, enge Türen, schwer zu öffnende Kleidung etc.)

Indikation:

- bei vorliegender Harninkontinenz bzw.
- zur Prophylaxe bzw.
- nach ärztlicher Anordnung
- als vereinbarte Leistung

Kontraindikation:

- bei Ablehnung des Patienten
- mit apallischem Syndrom sowie
- medizinischen Diagnosen, die mit erheblichen kognitiven Veränderungen verbunden sind und pflegerische Interventionen nicht umgesetzt werden können

Vorbereitung:

- Hände waschen und Händedesinfektion
- Patient informieren
- Materialien für die Pflegemaßnahmen bereitlegen

Material:

- leicht zu öffnende Kleidung, Inkontinenzhilfsmittel, Kennzeichnungshilfen für Toiletten, hindernisfreie Wege zur Toilette, angepasste WC-Sitze

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDEL/QMB	01.01.2023		001	I	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 – 17	Bezeichnung des Dokumentes: Förderung der Harnkontinenz in Anlehnung an den Expertenstandard „Förderung der Harnkontinenz in der Pflege“ 2014	

Durchführung:

- die erste pflegefachliche Einschätzung (bei Aufnahme) zu den individuellen pflegesensitiven Risiken und Phänomenen (ja-nein) ergibt sich aus den Erkenntnissen der Situationseinschätzung in den Themenfeldern durch die PFK unter der Rubrik relevantes Risiko und Phänomen in der „Strukturierten InformationsSammlung“ (SIS).
- Wird die Kategorie von der PFK mit „nein“ angekreuzt, liegt aus pflegefachlicher Sicht kein Risiko bzw. keine Einschränkung im Bereich Inkontinenz vor, es werden keine prophylaktischen Maßnahmen geplant und umgesetzt.
- Wird die Kategorie „ja“ angekreuzt, muss die PFK zusätzlich eine Entscheidung zu der Kategorie „vertiefende Einschätzung notwendig“ (ja-nein) treffen, um festzulegen, ob hierzu aus fachlicher Sicht die Notwendigkeit für ein weiteres Handeln besteht. Es sind die dargestellten Risiken und Ursachen des aktuellen Nationalen Expertenstandards heranzuziehen ggfls. ist die Maßnahmenplanung anzulegen oder anzupassen.
- tritt Inkontinenz als Phänomen später neu hinzu, erfolgt eine Eintragung im Berichtblatt und die Anpassung der Maßnahmenplanung
- Ist eine Beratung erfolgt, wird dies inhaltlich kurz im zutreffenden Themenfeld beschrieben und auf der SIS angekreuzt, später notwendig werdende Beratungen sind im Berichtblatt zu beschreiben
- grundsätzlich dient das Berichtblatt zur Erfassung veränderter pflegerischer Situationen als anlassbezogene Evaluation in akuten Situationen oder bei besonderen Ereignissen oder Veränderungen
- Bei Patienten, die nur Leistungen SGB V bzw. andere Leistungen als Hilfen bei der Ausscheidung aus dem Bereich SGB XI erhalten sind Auffälligkeiten im Rahmen des Risikomanagements zu bewerten, der Patient ist über das Ergebnis zu beraten
- Im Rahmen des Erstgesprächs ist der Patient vorsichtig und respektvoll nach seiner Kontinenzsituation befragen (Einwilligung des Patienten, ob Angehörige am Gespräch teilnehmen dürfen, passender Ort und Rahmenbedingungen).
- Oberster Grundsatz ist die Wahrung der Intimität.
- Folgende Initialfragen zur Identifikation einer vorliegenden Inkontinenz (Initiales Assessment) zu stellen:
 - a) Verlieren Sie ungewollt Urin?
 - b) Verlieren Sie Urin, wenn Sie husten, lachen oder sich körperlich betätigen?
 - c) Verlieren Sie Urin auf dem Weg zur Toilette?
 - d) Tragen Sie Vorlagen/Einlagen um Urin aufzufangen?
 - e) *Verspüren Sie häufig (starken) Harndrang?*
 - f) *Müssen Sie pressen, um Wasser zu lassen?*

Im Rahmen der Krankenbeobachtung sind Nebeninformationen zu berücksichtigen, wenn der Patient eine Harninkontinenz zwar verneint, aber andere Indizien dafür sprechen (z. B. starker Harngeruch)
- Bei Indizien auf Harninkontinenz durch sexualisierter Gewalt (bspw. Abwehrverhalten bei intimen Verrichtungen, nicht ohne weiteres erklärbares vaginale Blutungen oder Verletzungen im Intimbereich) aufgrund biografischer oder aktueller Erfahrung ist der Patient vorsichtig zu befragen, nonverbale Signale der Kommunikation sind zu berücksichtigen. Das Thema darf je nach Gesprächssituation unangesprochen gelassen werden.
- es sind Kontinenzprofile zu bestimmen (siehe Anlage). Ist eine weitere mögliche Verbesserung des Kontinenzprofils nicht zu erreichen, ist dies im Pflegebericht zu vermerken.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDEL/QMB	01.01.2023		001	2	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 – 17	Bezeichnung des Dokumentes: Förderung der Harnkontinenz in Anlehnung an den Expertenstandard „Förderung der Harnkontinenz in der Pflege“ 2014	

Maßnahmen der Kontinenzförderung sind:

- Patienten und Angehörige sind über die Problematik der Harninkontinenz aufzuklären und zu beraten
- Das Selbstbestimmungsrecht ist zu beachten.
- Den Flüssigkeitsstatus feststellen. Auf eine angemessene Flüssigkeitszufuhr, mindestens jedoch 1,5 l/täglich ist zu achten (mangelnde Flüssigkeitsaufnahme führt zu konzentriertem Urin und kann Drangsymptomatik verstärken), unter Umständen ist ein Trinknachweis/Trinkprotokoll anzulegen
- es kann hilfreich sein die Miktion zu beobachten
- Der **Vorlagengewichtstest** dient der Bestimmung des Inkontinenzgrades als messbare Ausgangsgröße, später zur Evaluation umgesetzter Maßnahmen und ist nur dort anzulegen, wo eine exakte Messung der abgehenden Harnmenge aus diagnostischen Gründen unbedingt erforderlich ist.
- Beim Vorlagengewichtstest sind die genutzten Vorlagen über einen Zeitraum von 24 h in einem Plastikbeutel zu sammeln, zu wiegen und demgegenüber die gleiche Anzahl von ungenutzten Vorlagen zu wiegen. Die Differenz stellt den Abgang von Urin in g bzw. ml dar und wird bei der Anamnese und zur Evaluation genutzt.

leichte Inkontinenz	300 - 600 ml
mittlere Inkontinenz	600 - 1200 ml
schwere Inkontinenz	1200 - 1800 ml
schwerste Inkontinenz	über 1800 ml

Achtung Abweichungen bei der Flüssigkeitszufuhr beachten!

- Der **Vorlagengewichtstest** dient auch der Bestimmung der angemessenen Vorlagengröße, hierzu die Ausscheidung über 4 h beobachten.
- Bei Notwendigkeit ist ein/e pflegerische Fachexpertin (PFE) für Kontinenzförderung hinzuziehen. In unserem Dienst ist: eingesetzt, sie/er verfügt über eine spezielle Weiterbildung und koordiniert notwendig werdende Maßnahmen (bspw. Fallbesprechungen, Maßnahmeplanung).
- In Teambesprechungen sind unter Beteiligung der „PFE für Kontinenzförderung“ Fallbesprechungen in regelmäßigen Abständen zur Situation und Entwicklung des Patienten durchzuführen, hierbei sind auch der Gesundheitsgewinn und die Lebensqualität des Patienten zu bewerten. Im Rahmen der Teambesprechungen sind individuelle Wünsche und Ausscheidungsgewohnheiten zu berücksichtigen
- Die Bestimmung des Restharns, die Urinanalyse sowie körperlichen Untersuchungen sind Aufgabe des Arztes als Teil der Diagnostik und Therapie.
- Förderung der Autonomie und Bewegungsfähigkeit (geeignete Gehhilfen, Handläufe, Haltestangen, ausreichende Beleuchtung, deutliche Beschilderung, Transfermöglichkeiten z.B. für das Umsetzen vom Rollstuhl zur Toilette, erhöhte Toilettensitze und Erreichbarkeit der Toilettenutensilien)
- Einsatz geeigneter Inkontinenzprodukte, Patienten über Inkontinenzmaterial aufklären (z.B. Einlagen, Kondomableitungen, Bettschutz)
- Hygiene und Hautpflege
- Das Tragen geeigneter Kleidung (vorzugsweise luftdurchlässig, Knöpfe und Reißverschlüsse lassen sich leicht öffnen)

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDEL/QMB	01.01.2023		001	3	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 – 17	Bezeichnung des Dokumentes: Förderung der Harnkontinenz in Anlehnung an den Expertenstandard „Förderung der Harnkontinenz in der Pflege“ 2014	

- Nutzung von Ritualen beim Ausscheiden, berücksichtigen persönlicher Gewohnheiten (Lesen der Zeitung, wohltemperiertes Bad, Hinsetzen oder Stehen, Geräusch fließenden Wassers etc.)
- Auf die Bitte um Hilfe bei der Ausscheidung ist unter Beachtung der individuellen Situation und möglicher Maßnahmen des Blasentrainings unverzüglich zu reagieren.
- Blasentraining mit dem Ziel: Erhöhung der Ausscheidungsintervalle auf 3-4 Stunden
- Beckenbodentraining (Stärkung des Beckenbodens durch aktives Kontrahieren vor allem bei Belastungsinkontinenz (Angebote der Physiotherapie), mit und ohne Hilfsmittel
- zielgerichtetes Toilettentraining ist nur bei Patienten anwenden, die auch davon profitieren
 - als angebotener Toilettengang
 - als Toilettengang zu individuellen Entleerungszeiten oder
 - als Toilettengang zu festgelegten Zeiten
- Der Einsatz von Hilfsmittel soll das Schamgefühl berücksichtigen und eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen.
- Die PFK steuert die Zusammenarbeit mit der „PFE für Kontinenzförderung“ im Pflegedienst bzw. mit anderen externen Berufsgruppen und teilt im Rahmen des Entlassungsmanagements den aufnehmenden Einrichtungen und Diensten die Informationen zur Kontinenzsituation des Patienten mit.
- ggf. nach ärztlicher AO die Versorgung mit einem Blasenkatheter nach hygienischen Grundsätzen

Nachbereitung:

- Abfall entsorgen
- Händedesinfektion
- Dokumentation der Leistungsdurchführung
- Dokumentation aller Auffälligkeiten des körperlichen und des seelischen Zustands oder Ablehnung von Pflegemaßnahmen
- Bei Notwendigkeit Anpassung der Maßnahmeplanung

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDEL/QMB	01.01.2023		001	4	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 – 17	Bezeichnung des Dokumentes: Förderung der Harnkontinenz in Anlehnung an den Expertenstandard „Förderung der Harnkontinenz in der Pflege“ 2014	

Einteilung der Kontinenzprofile

	Kontinenzprofil	Merkmal	Beispiel
1	Kontinenz	• kein unwillkürlicher Harnverlust • keine personelle Hilfe notwendig • keine Hilfsmittel	
2	unabhängig erreichte Kontinenz	• kein unwillkürlicher Harnverlust • keine personelle Unterstützung notwendig • selbstständige Durchführung von Maßnahmen	• z.B. Patienten/Bewohner, die durch eigenständige Medikamenteneinnahme, eigenständigen Gebrauch von mobilen Toilettenhilfen, intermittierendem Selbst-Katheterismus oder Durchführung von Trainingsmaßnahmen (z.B. Blasentraining) keinen unwillkürlichen Urinverlust haben
3	abhängig erreichte Kontinenz	• kein unwillkürlicher Harnverlust • personelle Unterstützung bei der Durchführung von Maßnahmen notwendig	• Patienten/Bewohner mit begleiteten Toilettengängen zu individuellen bzw. festgelegten Zeiten oder bei denen ein Fremd-Katheterismus durchgeführt wird
4	unabhängig kompensierte Inkontinenz	• unwillkürlicher Harnverlust • keine personelle Unterstützung bei der Versorgung mit Hilfsmitteln	• Es kommt zu einem unwillkürlichen Harnverlust, aber der Umgang mit Inkontinenz-Hilfsmitteln (aufsaugende Hilfsmittel, Kondomurinal, Blasenverweilkatheter) erfolgt selbstständig
5	abhängig kompensierte Inkontinenz	• unwillkürlicher Harnverlust • personelle Unterstützung bei der Inkontinenz-versorgung ist notwendig	• kompensierende Maßnahmen werden von einer dritten Person übernommen
6	nicht kompensierte Inkontinenz	• unwillkürlicher Harnverlust • personelle Unterstützung und therapeutische bzw. Versorgungsmaßnahmen werden nicht in Anspruch genommen	• dieses Profil trifft beispielsweise auf Betroffene zu, die nicht über ihre Inkontinenz sprechen wollen und deshalb keine personelle Hilfe oder Hilfsmittel in Anspruch nehmen bzw. aufgrund kognitiver Erkrankungen nicht akzeptieren oder die Hilfsmittel entfernen

Quelle: Expertenstand Förderung der Harnkontinenz in der Pflege (2014)

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDEL/QMB	01.01.2023		001	5	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 – 17	Bezeichnung des Dokumentes: Förderung der Harnkontinenz in Anlehnung an den Expertenstandard „Förderung der Harnkontinenz in der Pflege“ 2014	

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDEL/QMB	01.01.2023		001	6	Verw./MA